

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	腦瘤 Brain Tumor				
編號	A31000-Q03-W-K01	制定者	R12 林碧嵐	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.3 版/9 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解腦瘤的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳護理品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

腦瘤是組織的增生及異化，而對顱內造成傷害所產生的症狀，根據腦部功能不同所產生的症狀就不一樣，且其症狀的出現通常是含糊不清的，因此腦瘤是一種較難被早期確立診斷的疾病，通常發病到確立診斷已經經過一段時間，腦組織已經受到壓迫，需接受減壓治療，如:外科手術等。

（二）症狀

顱內腫瘤之症狀可分為四大類：顱內壓增高、癲癇發作、局部機能缺陷、及全身障礙，症狀可能同時出現，或個別出現，輕重不一。

1. 顱內壓增高：常見以下四項症狀

- (1)頭痛：好發於早晨，用力時加劇。
- (2)嘔吐：被形容為噴射狀嘔吐(projectile vomiting)。
- (3)視覺障礙：顱內壓增高所致之視乳頭水腫，易發生複視。
- (4)意識障礙：發生在顱內壓增高晚期。

2. 癲癇：癲癇不僅是腦瘤重要症狀之一，常常也是最早發生的症狀。

主題名稱	腦瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K01	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	2/9

3. 局部機能缺陷：解剖學上腦的個別區域受到腦瘤的侵犯時，會產生該區域所持有的神經機能失調的症狀，構成臨床症狀或症候群。
4. 全身障礙：可能因為代謝機能或內分泌失調引起生長、體型、性機能異常。
5. 焦慮：當病人因疾病面臨手術時，病人感受不適而產生焦慮反應，容易陷於負面情緒。腦瘤病人在確定診斷階段有心理困擾的問題存在，以焦慮最常見，認為源自於病人感到生命受威脅、對未來不確定。

（三）常見檢查

1. 電腦斷層掃描(Computerized Tomography；CT)。
2. 磁共振造影(Magnetic Resonance Image；MRI)。
3. 血管攝影(Angiography)。

（四）常見治療

1. 內科治療：

主要目標為降低顱內壓，可使用腎上腺皮質素及高滲透利尿劑。

2. 外科治療：

一般常用外科手術為：顱骨切開術與顱骨切除術，將腫瘤移除，有時也以腦室引流術來幫助減少顱內壓。

3. 化學治療：

目前多用於惡性膠質瘤作為輔助治療。

4. 放射線治療：

(1) 局部照射放射線同位素(^{125}I)，以抑制腫瘤細胞生長，或可於術前給予治療以縮小腫瘤。

(2) 立體定位放射線手術(Stereotatic radiosurgery, SRS)。

5. 治療方式：

(1) 開顱手術(craniotomy)。

(2) Chemotherapy(C/T)。

(3) Radiation therapy(R/T)。

主題名稱	腦瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K01	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	3/9

(五) 護理問題

1. 顱內壓力調適困難/大腦容量增加，如：腫瘤、顱內壓持續大於 15mmHg。
2. 疼痛不適/組織創傷（如：手術）。
3. 易跌倒/生理因素。

(六) 護理措施

1. 顱內壓力調適困難/大腦容量增加，如：腫瘤、顱內壓持續大於 15mmHg。
 - (1) 按時及必要時作神經功能、瞳孔反應、生命徵象的評估並記錄之。
 - (2) 觀察並記錄意識狀態的變化。
 - (3) 監測病人有無顱內壓增高症狀出現，並衛教顱內壓升高的危險性及徵象。
 - (4) 監測血液檢查值。
 - (5) 提供少刺激的環境，注意病人之安全性，教導使用床欄，必要時保護性約束，並向家屬解釋。
 - (6) 評估病人有無頭痛增加的情形，特別是在清晨；及有無伴隨噁心、嘔吐的症狀。
 - (7) 維持呼吸道通暢，必要時給予抽痰。
 - (8) 評估呼吸深度及型態，必要時監測動脈血中氧體。
 - (9) 依醫囑給予氧氣使用並監測血氧濃度以維持氧合。
 - (10) 依醫囑給予滲透性利尿劑、類固醇等，並注意病人用藥後反應。
 - (11) 觀察有無癲癇發作的情形，依醫囑給予抗癲癇藥物，並記錄其型態、時間等。
 - (12) 依醫囑限制水分攝取量，以預防腦浮腫加劇。
 - (13) 避免使用鎮定劑或麻醉劑，以免導致無法評估病人意識狀態。
 - (14) 記錄輸出入量，並評估是否達平衡。
 - (15) 教導維持身體姿勢成一直線避免臀部過度屈曲俯臥。
 - (16) 抬高床頭<30 度，以促進腦部靜脈回流及呼吸功能。
 - (17) 教導避免胸內壓與腹內壓的方法；如:避免用力咳嗽、用力解便、彎腰等。
 - (18) 教導病人避免伐氏操作法(Valsalvs's maneuver)及等長運動。

主題名稱	腦瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K01	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	4/9

(19) 建議採漸進式活動並避免過多的活動或突發動作。

(20) 監測顱內壓是否在護理活動及治療後有上升的情形，並視需要調整照護，儘量採集中護理。

2.疼痛不適/組織創傷（如：手術）

(1) 評估病人的疼痛程度及特徵。

(2) 評估疼痛加劇的原因。

(3) 減少或排除疼痛的因素。

(4) 教導放鬆技巧如：深呼吸、背部按摩、冥想。

(5) 予轉移注意力如：音樂、書籍、聊天。

(6) 予物理治療如：熱敷、冰敷。

(7) 病人選擇疼痛控制方法時，給予支持與指導。

(8) 家屬共同討論可控制引發疼痛的因素之方法。

(9) 避免哭鬧蹲姿、用力解便、咳嗽。

(10) 配合處方的止痛劑，以提供病人最理想的疼痛緩解。

(11) 持續評估病人的疼痛經驗，以評值疼痛控制措施的成效。

(12) 促使病人獲得充足的休息、睡眠以協助疼痛的緩解。

(13) 鼓勵家屬多予陪伴。

3.易跌倒/生理因素

(1) 病人臥床時使用床欄並注意床欄穩固。

(2) 降低病床高度。

(3) 使用夜燈的設置。

(4) 防滑墊、止滑鞋的穿著。

(5) 清除病床到浴室間的障礙物，保持地面乾燥及適當照明。

(6) 護理人員每班至少兩小時查看病人情形。

(7) 將尿壺或便盆置於可拿取位置且倒空。

(8) 讓病人及家屬瞭解目前之行動能力及限制，應採漸進式行動且有人在旁扶

主題名稱	腦瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K01	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	5/9

助。

(9)教導病人使用叫人鈴並置於適當位置。

(10)讓病人及家屬瞭解正在服用易導致跌倒的藥物，如:降血壓及安眠藥等。

(11)衛教病人在服用藥物後半小時內改變姿勢宜緩慢。

(12)必要時依醫囑給予適當的約束。

(七) 衛教指導

- 1.成人拍痰須知。
- 2.預防跌倒須知。
- 3.壓力性損傷的預防。
- 4.長期臥床病人之照護。
- 5.床上沐浴。
- 6.保護性約束。
- 7.癲癇。
- 8.一般傷口照護。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、 使用表單

(略)

五、 流程圖

(略)

六、 參考資料

- (一) 梁靜娟、溫美蓉、劉雅芬、張玉霞、穆佩芬(2020)·探討成年惡性腦瘤病人復發期護理人員照護經驗·榮總護理，37(4)，330-341。

主題名稱	腦瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K01	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	6/9

(二) 林佑蓉、吳元宏 (2020)・緩和性放射治療的臨床應用・臨床醫學月刊，85(1)，10-13。

(三) Ngai, C. H., Teo, C., Foo, J. Y., Lim, S., Koh, J. Q. S., Chan, H. M., Loh, N. W., & Teo, K. (2024). Application of a Standardized Treatment Paradigm as a Strategy to Achieve Optimal Onco-Functional Balance in Glioma Surgery. Brain tumor research and treatment, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.14791/btrt.2024.0011>

七、附件

(略)

主題名稱	腦瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K01	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	7/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	增加常見檢查：核磁共振掃描(Magnetic Resonance Image；MRI)。與血管攝影(Angiography)	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1.增加亞瑟刀治療，刪除伽瑪刀照射(r-knife)。 2.醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	修改常見檢查及治療部份。	102 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	說明內容修改治療方式部份。	103 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
104.08.31.	3.3	將年限較久參考文獻刪除並增加近期參考文獻，症狀部分加入焦慮。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.4	新增參考文獻出處於內文中。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.04.10	3.5	修改第三項第(五)目護理問題之部份內容。	106 年 04 月 10 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.6	新增第三項第(七)目之 8 衛教指導內容。	106 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	腦瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K01	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	8/9

修正日期	版本	修正說明	備註
107.09.12	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第六目之 1(10)(11)內容說明文字修訂。 3. 第三項第七目參考資料修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.05.15	3.8	1. 第三項第六目之 1 修訂為大腦容量增加如：腫瘤、顱內壓持續大於 15mmHg。 2. 第三項第六目之 1(7)(8)、之 2 說明內容修訂。 3. 第三項第七目之 3 壓瘡更改為壓力性損傷。 4. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 05 月 15 日護理長會議通過；108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	3.9	1. 第一項說明文字修訂。 2. 第三項第四目之 4 修訂治療方式為立體定位放射線手術(Stereotatic radiosurgery, SRS)。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過； 110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	4.0	1. 第三項第五目、第六目護理問題及護理措施內容部份修辭潤飾。 2. 第六項參考資料文獻部份內容更新。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過； 111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	4.1	第六項參考資料文獻部份內容更新。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過； 112 年 11 月 08 日護理長會議通過； 112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。

主題名稱	腦瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K01	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
113.12.17	4.2	1. 第三項第四目之 5.(2)(3)說明內容修訂。 2. 第三項第六目之 3.(9)說明內容修訂。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	4.3	第六項參考資料文獻部份內容更新。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。